Анализ форм приёма пациентов в частной клинике на основе требований МЗ РФ

Введение

Разработка системы приёма пациентов в частной медицинской организации требует глубокого понимания законодательной базы РФ и клинических особенностей различных ситуаций. С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые унифицированные формы первичной медицинской документации, утверждённые Приказом Минздрава России от 13 мая 2025 г. № 274н[1]. Данный документ представляет комплексный анализ форм приёма для разных клинических сценариев и рекомендации по созданию пула шаблонов для частной клиники.

1. Правовая база и общие требования

1.1 Основные нормативные документы

Документирование процесса приёма пациентов в частной клинике должно осуществляться в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Приказом Минздрава России от 13 мая 2025 г. № 274н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации»
- Приказом Минздрава России от 12 ноября 2021 г. № 1051н «Об утверждении Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство»
- Приказом Минздрава России от 02 апреля 2012 г. № 390н о перечне видов медицинских вмешательств[2]

1.2 Основные принципы организации приёма

Согласно законодательству РФ, организация приёма пациентов должна предусматривать:

- Возможность записи пациентов на прием через несколько каналов (телефон, личное обращение, электронные системы)
- Распределение потоков пациентов с учётом целей обращения (первичный приём, повторный приём, консультация, неотложная помощь)
- Оказание неотложной помощи без предварительной записи при экстренных показаниях
- Ведение унифицированной медицинской документации
- Получение информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство[1]

2. Основные формы первичной медицинской документации

2.1 Форма № 025/у - Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Назначение и область применения

Форма № 025/у является основным учётным медицинским документом медицинской организации, осуществляющей амбулаторный приём[2]. Заполняется на каждого пациента при первом обращении за амбулаторной помощью, за исключением:

- Пациентов по профилю «ортодонтия» (используется форма 043-1/у)
- Беременных, рожениц и родильниц по профилю «акушерство и гинекология» (специальный порядок)

Структура формы 025/у

Титульный лист содержит:

1. **Идентификационные данные пациента:**
   - Фамилия, имя, отчество (при наличии)
   - Дата рождения
   - Пол
   - Место жительства (адрес регистрации и фактического проживания)
   - Телефон для связи
   - Место работы (учёбы)
2. **Документы удостоверения личности:**
   - Вид документа, серия, номер
   - Код гражданства
   - СНИЛС
   - ИНН (при наличии)
3. **Страховая информация:**
   - Полис ОМС: серия и номер
   - Наименование страховой медицинской организации
   - Код категории льготы
   - Наличие инвалидности
4. **Сведения о диспансеризации:**
   - Группа здоровья
   - Заболевания, по поводу которых осуществляется диспансерное наблюдение (с кодами МКБ-10)

Основные разделы карты

Раздел 1. Первичный осмотр врачом-специалистом

- Дата осмотра и место проведения (на приёме, на дому, прочее)
- Специальность врача
- Жалобы пациента (по системам органов)
- Анамнез заболевания (начало, развитие, симптомы)
- Анамнез жизни (профессия, вредные привычки, аллергии, наследственность)

- Объективные данные обследования
- Предварительный диагноз
- План дополнительного обследования
- Назначения (исследования, консультации)
- Лекарственные препараты, физиотерапия
- Листок нетрудоспособности/справка
- Льготные рецепты
- **Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство**

Раздел 2. Записи о заключительных диагнозах

Фиксирует:

- Основной диагноз (с кодом МКБ-10)
- Сопутствующие диагнозы
- Осложнения
- Отметку о впервые выявленном заболевании

Раздел 3. Медицинское наблюдение в динамике

Содержит повторные записи при последующих визитах:

- Дату осмотра
- Жалобы
- Данные наблюдения в динамике
- Назначения
- Подпись врача

Раздел 4. Дополнительные сведения

- Этапный эпикриз
- Консультация заведующего отделением
- Заключение врачебной комиссии
- Данные о диспансерном наблюдении
- Информация о госпитализациях
- Информация об оперативных вмешательствах
- Сведения о полученных дозах облучения при рентгенологических исследованиях

Техника заполнения формы 025/у

Обязательные требования[3]:

- Заполняется на русском языке
- Используется шариковая ручка чёрного или синего цвета для бумажного варианта
- Информация должна быть чёткой, разборчивой и полной
- Исправления допускаются путём зачёркивания неправильного текста одной линией с проставлением подписи и даты
- Все записи должны быть подписаны врачом
- Запрещается использование средства для исправления текста (корректора, белила)

Кто может заполнять:

- Лечащий врач (обязательно)
- Медицинская сестра (под руководством врача для отдельных разделов)
- Работник регистратуры (титульный лист при первичном обращении)

2.2 Форма № 025-1/у - Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Назначение и область применения

Форма 025-1/у является документом первичной отчётности, заполняемым при каждом обращении пациента в амбулаторных условиях[1]. Используется для регистрации и учёта амбулаторных приёмов, формирования реестров по случаям обращений и статистического анализа.

Содержание и структура

Основные элементы талона:

1. **Информация о пациенте:**
   - Идентификационный номер пациента (СНИЛС или уникальный номер в системе клиники)
   - Фамилия, имя, отчество
   - Дата рождения
   - Пол
   - ОГРП (место постоянного проживания)
2. **Данные о приёме:**
   - Номер талона
   - Дата приёма
   - Время приёма (час, минуты)
   - Тип приёма (первичный, повторный, консультация, неотложный)
   - Место проведения приёма (код подразделения)
3. **Информация о медицинском работнике:**
   - Специальность врача/медицинского работника
   - Код врача (в системе клиники)
   - Должность
4. **Клинико-диагностическая информация:**
   - Поведённий основного диагноза (код МКБ-10)
   - Наличие осложнений
   - Указание на впервые выявленное заболевание
   - Наличие травмы
5. **Исходы приёма:**
   - Код результата осмотра (выздоровление, улучшение, без изменений, ухудшение)
   - Направленость маршрута (амбулаторное лечение, госпитализация, консультация)
6. **Организационные данные:**
   - Фактический адрес медицинской организации
   - Код по ОКАТО
   - Код вида медицинского учреждения

Функции талона в системе документации

- **Первичный учёт:** фиксирует каждый контакт пациента с медицинской организацией
- **Статистический анализ:** служит основой для формирования отчётности по объёму и качеству оказываемой помощи
- **Контроль качества:** отслеживает маршруты пациентов и результаты лечения
- **Финансовое обоснование:** в системе ОМС используется для расчёта стоимости оказанных услуг

2.3 Форма информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство

Правовое значение

Согласно статье 20 Федерального закона № 323-ФЗ, информированное добровольное согласие является **необходимым предварительным условием медицинского вмешательства**[2]. Отсутствие надлежащего согласия может служить основанием для привлечения к ответственности.

Исключения из требования согласия:

- Оказание экстренной медицинской помощи при угрозе жизни и невозможности получить согласие
- Судебное решение о принудительном лечении
- Иные случаи, предусмотренные законодательством

Структура и содержание согласия

Обязательные элементы формы согласия[4]:

1. **Идентификация пациента:**
   - Полные фамилия, имя, отчество
   - Статус (дееспособный гражданин, законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица)
2. **Описание медицинского вмешательства:**
   - Наименование конкретных процедур, манипуляций, операций
   - Цели и ожидаемые результаты
   - Альтернативные методы лечения (если имеются)
3. **Информирование о рисках:**
   - Возможные осложнения и побочные эффекты
   - Частота возникновения серьёзных осложнений
   - Возможные последствия отказа от лечения
4. **Условия отказа:**
   - Право пациента на отказ от вмешательства
   - Возможность отозвать согласие в любой момент
   - Информация о последствиях отказа
5. **Подписи и датирование:**
   - Подпись пациента (или законного представителя)
   - Подпись медицинского работника, получившего согласие
   - Дата оформления согласия
   - Для несовершеннолетних: подпись одного из родителей

Форматы оформления согласия

Бумажный носитель:

- Подписывается от руки пациентом и медицинским работником
- Хранится в медицинской документации пациента
- Рекомендуется использование печати медицинской организации

Электронный документ:

- Подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УЦП)
- Может использоваться простая электронная подпись через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации)
- Включается в электронную медицинскую карту пациента

---

3. Анализ форм приёма по различным клиническим ситуациям

3.1 Первичный приём в амбулаторных условиях

Определение и признаки

Согласно правилам внутреннего распорядка медицинских организаций, первичным приёмом считается первичное обращение пациента к конкретному врачу-специалисту в рамках договора об оказании медицинских услуг[1].

Процедура оформления

Этап 1 - Регистрация (регистратура):

- Пациент предъявляет документ, удостоверяющий личность
- Сообщаются ФИО, дата рождения, адрес проживания, контактный телефон
- Проверяется наличие полиса ОМС (для пациентов в системе ОМС)
- Заполняется титульный лист формы 025/у
- Пациенту выдаётся талон на приём к врачу
- Объясняется процедура приёма и ожидаемое время консультации

Этап 2 - Ознакомление пациента:

- Предоставляется информация о враче (специализация, квалификация)
- Пациент информируется о правах и обязанностях
- Вручается информационный материал о конфиденциальности медицинской информации

Этап 3 - Врачебный приём:

- Врач проводит первичный осмотр и опрос
- Собирается анамнез заболевания и жизни
- Проводится объективное обследование
- Ставится предварительный диагноз
- Назначается дополнительное обследование (если необходимо)

- **Получается информированное добровольное согласие** на планируемое медицинское вмешательство
- Выписываются рецепты, направления, справки
- Заполняются соответствующие разделы формы 025/у
- Назначается дата следующего приёма (при необходимости)
- Выдаётся талон формы 025-1/у

Этап 4 - Функции первичного приёма:

- Установление контакта "врач-пациент"
- Сбор полной информации о состоянии здоровья
- Первичная диагностика
- Определение дальнейшей тактики ведения
- Назначение лечебно-профилактических мероприятий

Рекомендуемые шаблоны документов для первичного приёма

Шаблон 1: Форма 025/у - Титульный лист первичного приёма

Содержит предварительно заполненные:

- Наименование медицинской организации
- Дата создания карты
- Поля для заполнения: ФИО пациента, дата рождения, контактные данные
- Предварительно отмеченные поля выбора специальности врача

Шаблон 2: Форма 025/у - Раздел "Первичный осмотр"

Структурированное описание с подсказками:

- Стандартная схема опроса по системам органов
- Перечень обязательных вопросов по системе главной жалобы
- Типовые разделы анамнеза
- Схема физикального обследования
- Места для стандартных кодов МКБ-10 по частым диагнозам в клинике

Шаблон 3: Информированное добровольное согласие (первичный приём)

Предварительно заполненные:

- Наименование клиники и врача
- Стандартные процедуры первичного осмотра
- Описание процедур диагностики (осмотр, пальпация, аускультация)
- Описание возможных рисков осмотра (минимальные для первичного обследования)
- Строки для подписей пациента и врача

3.2 Повторный приём (диспансерное наблюдение)

Определение и показания

Повторный приём осуществляется при последующих обращениях пациента к врачу более чем через один месяц с момента первого обращения, независимо от причины обращения[5]. Также повторный приём проводится при диспансерном наблюдении за хроническими заболеваниями.

Особенности документирования

Раздел формы 025/у - "Медицинское наблюдение в динамике":

- Используется для записи данных при повторных визитах
- Не требуется оформление нового согласия (если состояние пациента не изменилось и не планируются новые вмешательства)
- **Требуется новое согласие** при:
  - Изменении диагноза
  - Назначении инвазивных процедур
  - Смене метода лечения
  - Назначении рискованных лекарственных препаратов

Содержание записи при повторном приёме:

- Дата приёма
- Жалобы пациента и динамика их разрешения
- Эффективность проводимого лечения
- Переносимость медикаментов
- Результаты дополнительных исследований
- Изменения в объективном статусе
- Результат уточнённого диагноза
- Коррекция назначений (изменение дозировок, замена препаратов)
- Новые назначения и рекомендации

Тактические подходы при повторном приёме

В зависимости от результатов обследования:

1. **При улучшении состояния:**
   - Продолжение текущего лечения
   - Возможное снижение кратности приёмов
   - Подготовка к завершению лечения
   - Профилактические рекомендации
2. **При отсутствии улучшения:**
   - Пересмотр диагноза
   - Дополнительные исследования
   - Консультация специалиста
   - Коррекция лечения
3. **При ухудшении состояния:**
   - Экстренное обследование
   - Возможная госпитализация
   - Консультация врача-специалиста
   - Изменение тактики ведения

Рекомендуемые шаблоны для повторного приёма

Шаблон 4: Форма 025/у - "Медицинское наблюдение в динамике" (первый повторный приём)

Содержит:

- Предварительно заполненный диагноз
- Контрольный перечень симптомов для оценки динамики
- Шкалы оценки состояния (ВАШ, ВАШ - в зависимости от профиля)
- Типовые назначения при хорошей переносимости
- Схему модификации лечения при побочных эффектах

Шаблон 5: Форма 025/у - "Диспансерное наблюдение" (повторные приёмы)

Структурированная форма для регулярного диспансерного наблюдения:

- Таблица с датами запланированных приёмов
- Перечень обязательных исследований в зависимости от диагноза
- Критерии компенсации хронического заболевания
- Показания к консультации других специалистов

3.3 Консультативный приём

Определение и функции

Консультация - это приём пациента врачом-специалистом по направлению лечащего врача для уточнения диагноза, определения тактики лечения или решения конкретной проблемы[1].

Виды консультаций

1. **Первичная консультация специалиста:**
   - Первое обращение пациента к данному специалисту
   - По направлению от врача общей практики или другого специалиста
   - Часто сопровождается дополнительным осмотром и рекомендациями
2. **Повторная консультация:**
   - Повторное обращение к тому же специалисту через интервал более одного месяца
   - Для оценки результатов проведённого лечения
   - Для определения дальнейшей тактики
3. **Экстренная консультация:**
   - Проводится при неотложных состояниях
   - Без предварительной записи и направления

Особенности документирования консультативного приёма

На форме 025/у или отдельном направлении:

- Указание основного врача, направившего пациента
- Описание причины консультации (конкретный вопрос к специалисту)
- Полный объём информации о состоянии пациента
- Результаты предыдущих обследований (копии)

В медицинской карте консультирующего врача:

- Дата консультации
- Анализ жалоб и анамнеза
- Результаты специализированного осмотра
- Предварительное заключение специалиста
- Рекомендации по диагностике и лечению
- Предложение о дальнейшем ведении пациента

Рекомендуемые шаблоны для консультативного приёма

Шаблон 6: Направление на консультацию (врача-специалиста)

Содержит:

- ФИО пациента, дата рождения
- Диагноз направляющего врача
- Конкретный вопрос к специалисту
- Результаты уже проведённых исследований
- Текущее лечение
- Аллергологический статус
- Сроки желаемой консультации

Шаблон 7: Форма 025/у - Консультация специалиста

Структурированная форма:

- Вводная часть: копирование данных о пациенте, диагноза, причины обращения
- Раздел специалиста: осмотр по профилю, дополнительные методы исследования
- Заключение: диагноз по профилю или подтверждение/уточнение направившего врача
- Рекомендации: лечение, необходимые исследования, сроки повторной консультации
- Указание необходимости дополнительного лечения или наблюдения

3.4 Экстренный и неотложный приём

Правовые основания

Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ, медицинская организация обязана оказывать помощь в экстренной и неотложной форме без предварительной записи и прерывая обычный режим работы[2].

Экстренная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих **угрозу жизни пациента**[6].

Неотложная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний **без явных признаков угрозы жизни**, требующих срочного медицинского вмешательства.

Процедура оформления экстренного/неотложного приёма

Триаж (медицинская сортировка):

При поступлении пациента в экстренном/неотложном состоянии проводится медицинская сортировка для определения приоритетности и места оказания помощи.

Категории триажа:

1. **Красная зона (экстренная):** угрожающие жизни состояния, требующие немедленного вмешательства
2. **Жёлтая зона (неотложная):** состояния, требующие срочного вмешательства в ближайшие часы
3. **Зелёная зона (отложенная):** состояния, позволяющие отложить помощь без риска для жизни
4. **Чёрная зона:** состояния несовместимые с жизнью или наступившая смерть

Документирование экстренного/неотложного приёма

Форма экстренного приёма:

При невозможности заполнить полную форму 025/у из-за критичности состояния заполняется:

- **Краткая карта экстренного приёма** с информацией:
  - Время поступления
  - Предварительный диагноз
  - Проведённые мероприятия
  - Результаты
  - Решение о дальнейшей тактике (госпитализация, направление в стационар, амбулаторное лечение)

После стабилизации состояния:

- Заполнение полной формы 025/у с ретроспективным описанием
- Указание времени поступления, диагноза, проведённого лечения
- Обязательное отражение: "Экстренный приём" или "Неотложный приём"
- Запись о согласии пациента (если состояние позволило его получить)

Показания для экстренного приёма

- Потеря сознания или нарушение сознания (спутанность, возбуждение)
- Затрудненное дыхание или остановка дыхания
- Боли в груди с признаками сердечного происхождения
- Резкие, невыносимые боли в животе
- Кровотечение (внутреннее или наружное)
- Судороги
- Внезапный парез или паралич
- Острые нарушения зрения
- Приступ удушья
- Признаки острого отравления
- Тяжёлые травмы

Показания для неотложного приёма

- Острые инфекционные заболевания с лихорадкой (температура >38,5°C)
- Острый гастроэнтерит (рвота, понос без признаков дегидратации)
- Острый отит (боли в ухе)
- Острый синусит (боли в лице)
- Острый цистит (дизурия)
- Обострение хронического бронхита с кашлем
- Острые аллергические реакции (без анафилаксии)
- Боли в суставах с отёком (без травмы)
- Острая крапивница
- Диарея с колик

Рекомендуемые шаблоны для экстренного/неотложного приёма

Шаблон 8: Форма экстренного приёма (краткая)

Содержит:

- Время поступления (час, минута)
- Способ доставки (самостоятельно, СМП, сопровождающий)
- Предварительный диагноз (дифференциальный ряд)
- Шкала тяжести (Шкала Апгар, Glasgow Coma Scale в зависимости от ситуации)
- Проведённые мероприятия (в хронологическом порядке)
- Результат лечения (улучшение, без изменений, ухудшение)
- Решение: амбулаторное лечение / госпитализация / направление в стационар

Шаблон 9: Согласие на экстренное медицинское вмешательство

Специальная форма:

- Возможность получения согласия устно с фиксацией в карте
- Если пациент без сознания: указание причины невозможности получить согласие
- Указание на согласие законного представителя (при наличии)
- При отсутствии возможности получить согласие: документирование факта оказания помощи по жизненным показаниям

Шаблон 10: Направление в стационар при экстренном приёме

Содержит:

- Срочность доставки (немедленно, в течение часа, в течение суток)
- Вид транспорта (СМП, специальный транспорт, самостоятельно)
- Показания для госпитализации
- Диагноз направляющего врача
- Проведённые в поликлинике мероприятия и их результат
- Противопоказания к определённым методам лечения
- Назначение для продолжения в стационаре

3.5 Приём беременных и рожениц

Правовые и клинические особенности

Приём беременных, рожениц и родильниц имеет существенные отличия от стандартного приёма. Согласно приказу Минздрава № 274н, для этой категории пациентов **не используется форма 025/у в стандартном виде**, а применяется специальный порядок документирования[1].

Документирование приёма беременных

Основной документ: Обменная карта беременной и родильницы (форма, утверждённая специально для акушерского стационара)[3].

На амбулаторном этапе используется:

- Индивидуальная карта беременной (форма 111/у)
- Карта диспансеризации беременных
- При первичном обращении: сбор полного акушерского анамнеза

Содержание первичного приёма беременной:

1. **Анамнез репродуктивной системы:**
    - Менструальная функция (возраст менархе, длительность цикла, характер менструаций)
    - История предыдущих беременностей (кол-во, исходы, осложнения)
    - История родов, абортов, выкидышей
    - Интергенетический интервал
2. **Сведения о текущей беременности:**
    - Дата последней менструации
    - Дата первого обращения
    - Предполагаемый срок родов
    - Результаты УЗИ (скрининг первого триместра)
3. **Объективное обследование:**
    - Общее состояние, витальные показатели
    - Измерение артериального давления на обеих руках
    - Определение высоты дна матки (ВДМ)
    - Определение окружности живота
    - Аускультация сердцебиения плода
    - Влагалищное исследование (при показаниях)
4. **Лабораторно-инструментальные исследования:**
    - Общий анализ крови
    - Определение группы крови и резус-фактора
    - Анализ мочи
    - Анализ на TORCH-инфекции
    - УЗИ в сроки скрининга
    - Консультация при необходимости

Рекомендуемые шаблоны для приёма беременных

Шаблон 11: Первичный приём беременной

Содержит:

- Расширенный акушерский анамнез
- Шкала оценки акушерского риска
- Определение наличия факторов риска
- План диспансеризации и исследований
- Рекомендации по образу жизни во время беременности
- Сроки следующих приёмов согласно стандартам

Шаблон 12: Повторный приём беременной (триместр)

Структурированная форма:

- Оценка состояния и переносимости беременности
- Контроль артериального давления
- Контроль прибавки веса
- Измерение ВДМ и окружности живота
- Наличие отёков, протеинурии
- Результаты анализов
- Коррекция рекомендаций

3.6 Приём детей (педиатрический приём)

Особенности педиатрического приёма

Приём детей имеет специфику, связанную с возрастными особенностями и необходимостью учёта интересов несовершеннолетнего пациента.

Возрастные группы при приёме:

1. **Новорождённые (0-28 дней)** - требуют особого подхода и скрининга
2. **Грудные дети (1-12 месяцев)** - частые профилактические осмотры, прививки
3. **Ясельный возраст (1-3 года)** - диспансеризация, профилактика инфекций
4. **Дошкольный возраст (3-7 лет)** - подготовка к школе, скрининг
5. **Школьный возраст (7-17 лет)** - периодические осмотры, формирование здоровья

Документирование приёма детей

Участие законного представителя:

- Согласие должно быть подписано родителем или законным представителем
- Для детей старше 14-15 лет (в зависимости от региона) возможно собственное согласие на простые процедуры
- Для инвазивных процедур согласие родителя обязательно даже для детей старше 18 лет

Специальные разделы в карте ребёнка:

- Сведения о родовспоможении (срок беременности, вес при рождении, оценка по Апгар)
- История вскармливания (грудное, смешанное, искусственное)
- Календарь прививок
- Данные о профилактических осмотрах
- Сведения о перенесённых инфекциях

Рекомендуемые шаблоны для педиатрического приёма

Шаблон 13: Первичный приём новорождённого

Содержит:

- Данные о родах (срок, тип родоразрешения, вес, оценка по Апгар)
- Первичный осмотр в роддоме
- Скрининг на врождённые пороки развития
- Необходимые исследования в неонатальный период
- Рекомендации по вскармливанию и уходу

Шаблон 14: Профилактический осмотр ребёнка раннего возраста

Структурированная форма:

- Оценка физического развития (рост, вес, окружность головы)
- Оценка нервно-психического развития
- Проверка календаря прививок
- Профилактическое лечение (витамины, фторирование, профилактика рахита)
- Консультирование родителей
- Назначение сроков следующего осмотра

Шаблон 15: Согласие родителя/опекуна на медицинское вмешательство для ребёнка

Специальная форма:

- Указание данных ребёнка и родителя/опекуна
- Описание процедур в доступной форме
- Информация о правах ребёнка
- Возможность родителя находиться при процедуре
- Подпись родителя/опекуна

---

4. Сводная матрица форм приёма и документов по ситуациям

Ситуация приёма	Форма 025/у	Форма 025-1/у	Согласие	Н
Первичный приём	Обязательно	Да	Обязательно	
Повторный приём	Раздел "Динамика"	Да	При необходимости	
Консультация специалиста	Раздел консультации	Да	При инвазивных процедурах	Об
Экстренный приём	Краткая форма	Да (срочно)	При возможности	не
Неотложный приём	Да	Да	При возможности	не
Приём беременной	Спец. форма	Да	Обязательно	
Приём ребёнка	Модифицированная	Да	Согласие родителя	

Table 1: Формы документации в зависимости от вида приёма

---

5. Рекомендуемый пул шаблонов для частной клиники

Основной набор шаблонов (обязательные)

Шаблон	Предназначение	Ключевые элементы	Периодичность использования
Шаблон 1	Титульный лист 025/у для первичного приёма	ФИО, паспортные данные, полис ОМС, место работы	Каждый первичный пациент
Шаблон 2	Первичный осмотр (раздел 025/у)	Жалобы, анамнез, объективный статус, диагноз	Каждый первичный пациент
Шаблон 3	Информированное согласие (стандартное)	Описание процедур, риски, подписи	Каждый первичный пациент
Шаблон 4	Повторный приём (динамика)	Жалобы, данные обследования, эффективность лечения	Каждый повторный пациент
Шаблон 5	Диспансерное наблюдение	График приёмов, критерии компенсации	Пациенты с хроническими заболеваниями
Шаблон 6	Направление на консультацию	Причина консультации, вопрос к специалисту, результаты	При необходимости консультации
Шаблон 7	Консультация специалиста	Мнение специалиста, рекомендации	При обращении пациента
Шаблон 8	Экстренный приём (краткая форма)	Время, диагноз, проведённые мероприятия, результат	При экстренном обращении
Шаблон	Согласие на экстренное	Причина экстренности,	При экстренном

Шаблон	Предназначение	Ключевые элементы	Периодичность использования
9	вмешательство	согласие/отказ	приёме
Шаблон 10	Направление в стационар	Диагноз, показания, проведённое лечение	При необходимости госпитализации

Специальные шаблоны (по специальностям)

Специальность	Шаблоны	Специфические элементы
Терапия/ОВП	1-10 + расширенная 2	Полисистемное обследование, ФВД-тесты
Кардиология	1-10 + специальные ЭКГ	ЭКГ-интерпретация, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
Гастроэнтерология	1-10 + уточняющие вопросы	Диета, эндоскопия, pH-метрия
Пульмонология	1-10 + ФВД	Рентгенография, спирометрия, туберкулёзный скрининг
Неврология	1-10 + неврологический статус	Черепно-мозговые нервы, рефлексы, МРТ
Оториноларингология	1-10 + отоскопия	Отоскопия, риноскопия, фарингоскопия
Гинекология	1-10 + гинеко-осмотр (взрослые)	УЗИ-малого таза, цитология
Педиатрия	1-10 (модифицированные) + согласие родителя	Антропометрия, НПР, календарь прививок
Хирургия	1-10 + предоперационное обследование	Уровень хирургического риска, показания к операции
Дерматология	1-10 + дерматоскопия	Описание морфологии элементов, биопсия
УЗД	Протокол УЗИ	Технические параметры, интерпретация находок
Лабораторная	Результаты анализов	Единицы измерения, референсные значения

Специальность	Шаблоны	Специфические элементы
диагностика		

Рекомендации по внедрению пула шаблонов

1. **Электронный формат:** Рекомендуется использование медицинской информационной системы (МИС) с готовыми электронными формами 025/у и 025-1/у
2. **Печатный формат:** Для клиник без МИС - заказ бланков на полиграфических предприятиях с предварительным заполнением реквизитов клиники
3. **Обучение персонала:** Все сотрудники должны пройти обучение по правилам заполнения форм согласно приказу Минздрава
4. **Контроль качества:** Руководитель клиники или назначенное лицо должны проводить еженедельную проверку заполнения документов
5. **Учёт нормативных изменений:** Необходимо ежегодное обновление шаблонов в соответствии с новыми приказами Минздрава

---

6. Заключение

Система форм приёма пациентов в частной клинике должна быть гибкой, но соответствовать требованиям законодательства РФ. Основная сложность заключается в балансировании между полнотой документирования, необходимой для качества медицинской помощи, и эффективностью процесса приёма.

Ключевые рекомендации:

1. Использовать унифицированные формы МЗ РФ (025/у, 025-1/у) как основу системы документирования
2. Разработать специализированные шаблоны для каждого типа приёма и каждой специальности
3. Обеспечить все специалистов переводами стандартизованного инструментария для быстрого заполнения
4. Внедрить электронную форму документирования при возможности
5. Проводить регулярное обучение персонала
6. Ежегодно актуализировать шаблоны согласно новым приказам Минздрава

Грамотная система документирования приёма пациентов является основой качественной медицинской помощи и защиты прав как пациентов, так и медицинской организации.

Список использованных источников

[1] Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 274н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (с изменениями и дополнениями)

[2] Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

[3] Приказ Минздрава России от 2 апреля 2012 г. № 390н «Об утверждении перечня видов медицинских вмешательств, при оказании которых в целях информирования граждан о возможных осложнениях ненадлежащего оказания медицинской помощи допускается использование вспомогательных средств»

[4] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2021 г. № 1051н «Об утверждении Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства»

[5] Правила внутреннего распорядка медицинских организаций (типовые положения)

[6] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Положения об организации оказания скорой медицинской помощи»